

보건복지부 고시 제2025-177호

「국민건강보험법」 제41조제3항 및 제4항, 「국민건강보험 요양급여 기준에 관한 규칙」 제5조제2항에 따라 「요양급여의 적용기준 및 방법에 관한 세부사항」 (보건복지부 고시 제2025-169호(2025. 9. 26.))을 다음과 같이 개정·발령합니다.

2025년 10월 29일

보건복지부장관

「요양급여의 적용기준 및 방법에 관한 세부사항」 일부개정

요양급여의 적용기준 및 방법에 대한 세부사항 일부를 다음과 같이 개정한다.

Ⅱ. 약제 "[일반원칙] 경구용 만성 B형간염치료제, [일반원칙] 당뇨병용제, [629] Ledipasvir+Sofosbuvir 경구제(품명: 하보니정), [629] Sofosbuvir+Velpatasvir 경구제(품명: 애플루사정), [639] Ravulizumab 주사제(품명: 울토미리스주 등)"의 세부 인정기준 및 방법의 일부를 별지 2와 같이 변경한다.

부 칙

이 고시는 2025년 11월 1일부터 시행한다.

변경대비표

[별지 2]

[일반원칙]			
구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
[일반원칙] 경구용 만성 B형간염치료제	1. 허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. 다만, 시럽제의 경우는 시럽제의 투여가 반드시 필요한 경우에 한함. - 아 래 - 가. 초치료 시 1) 대상환자 가) (생 략) 나) 간경변, 간세포암종을 동반한 만성활동성 B형간염 환자: HBV-DNA 양성인 경우 - 단, Besifovir는 비대상성 간경변증에 인정하지 아니하며, <u>Tenofovir alafenamide 경구제는 비대상성 간경변증 환자에서 신기능 저하 또는 골다공증이 있는 경우에 요양급여를 인정함.</u> 2) 투여방법 가) Lamivudine, Clevudine, Telbivudine, Entecavir	1. 허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. 다만, 시럽제의 경우는 시럽제의 투여가 반드시 필요한 경우에 한함. - 아 래 - 가. 초치료 시 1) 대상환자 가) (현행과 같음) 나) 간경변, 간세포암종을 동반한 만성활동성 B형간염 환자: HBV-DNA 양성인 경우 - 단, Besifovir는 비대상성 간경변증에 인정하지 아니함. <삭 제> 2) 투여방법 가) Lamivudine, Clevudine, Telbivudine, Entecavir	○ 교과서, 가이드라인, 임상연구문헌, 전문가 의견 등을 참조하여 비대상성 간경변증을 동반한 만성활동성 B형간염 환자의 초치료, B형간염으로 간이식을 받은 환자, B형간염 예방요법, B형간염 수직 감염 예방 시 Tenofovir alafenamide 경구제의 급여를 확대함. ○ 대한간학회 진료 가이드라인 등을 참고하여 내성 발현 시 투여방법표를 개정함.

[일반원칙]

구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
	0.5mg, Adefovir, Tenofovir disoproxil, Tenofovir alafenamide, Besifovir 경구제 중 1종 나) Lamivudine 경구제는 만성 B형간염 치료를 처음으로 시작하는 환자로서 Lamivudine 제제보다 높은 유전적 장벽(genetic barrier)이 있는 다른 항바이러스제를 사용할 수 없거나 적절하지 않은 경우에 한하며, 투여소견서를 첨부하여야 함. 다) Besifovir 경구제는 L-carnitine 660mg을 함께 투여함. <u>라) 가. 초치료 시 1) 대상환자 기준조건을 충족하여 Tenofovir alafenamide 또는 Besifovir 경구제로 치료를 시작한 환자가 B형간염 치료 도중 간세포암종으로 진행된 경우에 한하여 치료 중인 각 약제의 지속투여를 인정함.</u> 나. 내성 발현 시 1) 대상환자 Lamivudine, Clevudine, Telbivudine, Entecavir,	0.5mg, Adefovir, Tenofovir disoproxil, Tenofovir alafenamide, Besifovir 경구제 중 1종 나) Lamivudine 경구제는 만성 B형간염 치료를 처음으로 시작하는 환자로서 Lamivudine 제제보다 높은 유전적 장벽(genetic barrier)이 있는 다른 항바이러스제를 사용할 수 없거나 적절하지 않은 경우에 한하며, 투여소견서를 첨부하여야 함. 다) Besifovir 경구제는 L-carnitine 660mg을 함께 투여함. <u><삭 제></u> 나. 내성 발현 시 1) 대상환자 Lamivudine, Clevudine, Telbivudine, Entecavir,	○ 급여 확대에 따른 관련 문구 정비 등 ○ B형간염 재활성화 위험도 판단은 최신 가이드라인을 따름을 명확히 함.

[일반원칙]

구 분	세부인정기준 및 방법						사유																																																												
	현 행			개 정(안)																																																															
	Adefovir 경구제 사용 후 다음과 같은 기준을 충족하는 내성 변이종 출현 환자 - 다 음 - 가) ~ 나) (생 략)			Adefovir 경구제 사용 후 다음과 같은 기준을 충족하는 내성 변이종 출현 환자 - 다 음 - 가) ~ 나) (현행과 같음)																																																															
	2) 투여방법			2) 투여방법																																																															
	<table><tr><th rowspan="3">내성 약제</th><th colspan="5">치료약제</th></tr><tr><th colspan="2">단독요법</th><th colspan="3">병용요법</th></tr><tr><th>entecavir 1mg</th><th>tenofovir disoproxil 또는 tenofovir alafenic</th><th>(lamivudine 또는 clevudine 또는 telbivudine) + (adefovir 또는 tenofovir disoproxil)</th><th>entecavir 0.5mg + (adefovir 또는 tenofovir disoproxil)</th><th>entecavir 1mg + (adefovir 또는 tenofovir disoproxil)</th></tr><tr><td rowspan="4">단독내성</td><td>lamivudine</td><td>인정</td><td>인정</td><td>인정</td><td></td><td></td></tr><tr><td>clevudine</td><td>인정</td><td>인정</td><td>인정</td><td></td><td></td></tr><tr><td>telbivudine</td><td>인정</td><td>인정</td><td>인정</td><td></td><td></td></tr><tr><td>adefovir</td><td>인정</td><td>인정</td><td>인정</td><td></td><td>인정</td></tr><tr><td rowspan="3">다약제내성</td><td>entecavir 0.5mg</td><td></td><td>인정</td><td></td><td>인정</td><td></td></tr><tr><td>entecavir 1mg</td><td></td><td>인정</td><td></td><td></td><td>인정</td></tr><tr><td>adefovir</td><td></td><td>인정</td><td>인정^주</td><td></td><td>인정</td></tr></table>						내성 약제	치료약제					단독요법		병용요법			entecavir 1mg	tenofovir disoproxil 또는 tenofovir alafenic	(lamivudine 또는 clevudine 또는 telbivudine) + (adefovir 또는 tenofovir disoproxil)	entecavir 0.5mg + (adefovir 또는 tenofovir disoproxil)	entecavir 1mg + (adefovir 또는 tenofovir disoproxil)	단독내성	lamivudine	인정	인정	인정			clevudine	인정	인정	인정			telbivudine	인정	인정	인정			adefovir	인정	인정	인정		인정	다약제내성	entecavir 0.5mg		인정		인정		entecavir 1mg		인정			인정	adefovir		인정	인정 ^주		인정	
내성 약제	치료약제																																																																		
	단독요법		병용요법																																																																
	entecavir 1mg	tenofovir disoproxil 또는 tenofovir alafenic	(lamivudine 또는 clevudine 또는 telbivudine) + (adefovir 또는 tenofovir disoproxil)	entecavir 0.5mg + (adefovir 또는 tenofovir disoproxil)	entecavir 1mg + (adefovir 또는 tenofovir disoproxil)																																																														
단독내성	lamivudine	인정	인정	인정																																																															
	clevudine	인정	인정	인정																																																															
	telbivudine	인정	인정	인정																																																															
	adefovir	인정	인정	인정		인정																																																													
다약제내성	entecavir 0.5mg		인정		인정																																																														
	entecavir 1mg		인정			인정																																																													
	adefovir		인정	인정 ^주		인정																																																													
	<table><tr><th rowspan="2">내성 약제</th><th rowspan="2">치료가능한 약제</th><th>tenofovir^{주2}</th><th>entecavir^{주3} + adefovir</th><th>entecavir^{주3} + tenofovir^{주2}</th><th>lamivudine /telbivudine + adefovir</th><th>lamivudine /telbivudine + tenofovir^{주2}</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">단독내성</td><td>lamivudine /clevudine /telbivudine</td><td>인정</td><td>-</td><td>-</td><td>인정</td><td>인정</td></tr><tr><td>entecavir</td><td>인정</td><td>인정</td><td>인정</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>adefovir</td><td>인정</td><td>인정</td><td>인정</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td colspan="2">다약제내성^{주1}</td><td>인정</td><td>-</td><td>인정</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>						내성 약제	치료가능한 약제	tenofovir ^{주2}	entecavir ^{주3} + adefovir	entecavir ^{주3} + tenofovir ^{주2}	lamivudine /telbivudine + adefovir	lamivudine /telbivudine + tenofovir ^{주2}						단독내성	lamivudine /clevudine /telbivudine	인정	-	-	인정	인정	entecavir	인정	인정	인정	-	-	adefovir	인정	인정	인정	-	-	다약제내성 ^{주1}		인정	-	인정	-	-																							
내성 약제	치료가능한 약제	tenofovir ^{주2}	entecavir ^{주3} + adefovir	entecavir ^{주3} + tenofovir ^{주2}	lamivudine /telbivudine + adefovir	lamivudine /telbivudine + tenofovir ^{주2}																																																													
단독내성	lamivudine /clevudine /telbivudine	인정	-	-	인정	인정																																																													
	entecavir	인정	인정	인정	-	-																																																													
	adefovir	인정	인정	인정	-	-																																																													
다약제내성 ^{주1}		인정	-	인정	-	-																																																													
	주1) 다른 계열의 두 가지 이상의 약제에 대한 내성변이를 경험한 경우를 말하며, 다른 계열이란																																																																		

[일반원칙]

구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
	주) lamivudine(또는 clevudine 또는 telbivudine) 내성 이후 발현한 순차내성에 한해 tenofovir disoproxil 병용요법을 인정함. ○ 나. 내성 발현 시 1) 대상환자 기준조건을 충족하여 Tenofovir alafenamide 경구제를 투여한 환자가 B형간염 치료 도중 간세포염증으로 진행한 경우에 한하여 Tenofovir alafenamide 경구제의 지속투여를 인정함. 다. ~ 마. (생 략) 2. 허가사항 범위를 초과하여 아래와 같이 투여한 경우에도 요양급여를 인정함. - 아 래 - 가. B형간염으로 간이식을 받은 환자: Lamivudine, Clevudine, Telbivudine, Entecavir 0.5mg, Adefovir, Tenofovir disoproxil 경구제 중 1종	nucleoside 유사체(lamivudine, clevudine, telbivudine, entecavir)와 nucleotide 유사체(adefovir, tenofovir disoproxil, tenofovir alafenamide)를 의미함. 주2) Tenofovir disoproxil 또는 Tenofovir alafenamide 주3) Entecavir 투여 중 내성 발현으로 타 약제와 병용하는 경우 이전 Entecavir 투여 용량을 유지하여야 함. 다. ~ 마. (현행과 같음) 2. 허가사항 범위를 초과하여 아래와 같이 투여한 경우에도 요양급여를 인정함. - 아 래 - 가. B형간염으로 간이식을 받은 환자: Lamivudine, Clevudine, Telbivudine, Entecavir 0.5mg, Adefovir, Tenofovir disoproxil, Tenofovir	

[일반원칙]

구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
	(단, Lamivudine 경구제는 만성 B형간염 치료를 처음으로 시작하는 환자로서 Lamivudine 제제보다 높은 유전적 장벽(genetic barrier)이 있는 다른 항바이러스제를 사용할 수 없거나 적절하지 않은 경우에 한하며, 투여소견서를 첨부하여야 함) <u>나. 간이식 전에 Entecavir 1mg, Adefovir 또는 Tenofovir disoproxil를 투여 받은 환자로서 B형간염으로 간이식을 받은 환자: Entecavir 1mg, Adefovir, Tenofovir disoproxil 경구제 중 1종</u> <u>- 단, 가. 초치료 시 1) 대상환자 조건을 충족하여 Tenofovir alafenamide로 치료를 시작한 환자 또는 나. 내성 발현 시 1) 대상환자 조건을 충족하여 Tenofovir alafenamide를 투여한 환자가 B형간염 치료 도중 간이식을 받게 된 경우에 한하여 Tenofovir alafenamide 경구제의 지속투여를 인정함.</u> 다. 소아환자	<u>alafenamide <추 가> 경구제 중 1종</u> (단, Lamivudine 경구제는 만성 B형간염 치료를 처음으로 시작하는 환자로서 Lamivudine 제제보다 높은 유전적 장벽(genetic barrier)이 있는 다른 항바이러스제를 사용할 수 없거나 적절하지 않은 경우에 한하며, 투여소견서를 첨부하여야 함) <u>나. <삭 제></u> <u>나. 소아환자</u>	

[일반원칙]			
구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
	1) 초치료 시 가) 대상환자: 만 12세 이상 18세 미만 환자 나) 투여방법: Adefovir 경구제 2) 내성 발현 시 가) 대상환자: Lamivudine에 내성변이종이 출현한 만 18세 미만 만성 B형간염 소아환자 나) 투여방법 ○ Lamivudine과 Adefovir의 병용투여 3. 허가사항을 초과하여 B형간염 예방요법으로서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정함. - 아 래 - 가. HBsAg(+) 또는 HBV-DNA(+)로서 B형간염 재활성화 위험이 중등도·고위험군에 해당하는 항암화학요법 (cytotoxic chemotherapy) 또는 면역억제요법을 받는 환자에게 투여 시 : 해당 요법 시행 동안 및 요법 종료 후 6개월까지	1) 초치료 시 가) 대상환자: 만 12세 이상 18세 미만 환자 나) 투여방법: Adefovir 경구제 2) 내성 발현 시 가) 대상환자: Lamivudine에 내성변이종이 출현한 만 18세 미만 만성 B형간염 소아환자 나) 투여방법 ○ Lamivudine과 Adefovir의 병용투여 3. 허가사항을 초과하여 B형간염 예방요법으로서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정함. - 아 래 - 가. HBsAg(+) 또는 HBV-DNA(+)로서 B형간염 재활성화 위험*이 중등도·고위험군에 해당하는 항암화학요법 (cytotoxic chemotherapy) 또는 면역억제요법을 받는 환자에게 투여 시 : 해당 요법 시행 동안 및 요법 종료 후 6개월까지 <u>*위험도 판단은 최신 가이드라인을 따라 적용함</u> <u><추 가></u>	

[일반원칙]

구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
	나. anti-HBc(+)로서 rituximab을 포함하는 요법을 투여하는 환자에게 투여 시 : 해당 요법 시행 동안 및 요법 종료 후 12개월까지 다. HBsAg(-), HBV-DNA(-), anti-HBc(+)로서 조혈모세포이식을 받는 만성 B형간염 환자에게 투여 시 : 총 18개월 투여까지 라. anti-HBc(+)인 공여자로부터 간을 공여 받는 수혜자로서 human anti-hepatitisB immunoglobulin 제제를 투여하지 않는 환자에게 투여 시 : 면역억제 요법 시행 동안 및 요법 종료 후 6개월까지 ※ 대상 약제 Lamivudine, Clevudine, Telbivudine, Entecavir, Adefovir, Tenofovir disoproxil 경구제	나. anti-HBc(+)로서 rituximab을 포함하는 요법을 투여하는 환자에게 투여 시 : 해당 요법 시행 동안 및 요법 종료 후 12개월까지 다. HBsAg(-), HBV-DNA(-), anti-HBc(+)로서 조혈모세포이식을 받는 만성 B형간염 환자에게 투여 시 : 총 18개월 투여까지 라. anti-HBc(+)인 공여자로부터 간을 공여 받는 수혜자로서 human anti-hepatitisB immunoglobulin 제제를 투여하지 않는 환자에게 투여 시 : 면역억제 요법 시행 동안 및 요법 종료 후 6개월까지 ※ 대상 약제 Lamivudine, Clevudine, Telbivudine, Entecavir, Adefovir, Tenofovir disoproxil, <u>Tenofovir alafenamide <추 가></u> 경구제	
4.	허가사항을 초과하여 B형간염 예방요법으로서 아래와 같은 기준으로 투여 시 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 -	4. 허가사항을 초과하여 B형간염 예방요법으로서 아래와 같은 기준으로 투여 시 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 -	

[일반원칙]

구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
	가. 3항의 각 투여기간 이후 나. HBsAg(+) 또는 HBV-DNA(+)로서 B형간염 재활성화 위험이 저위험군에 해당하는 항암화학요법(cytotoxic chemotherapy) 또는 면역억제요법을 받는 환자에게 투여하는 경우 ※ 대상 약제 Lamivudine, Clevudine, Telbivudine, Entecavir, Adefovir, Tenofovir disoproxil 경구제 5. B형간염 수직감염 예방 목적으로 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정함. - 아 래 - 가. 투여대상 ○ HBsAg(+)인 임산부로서 HBV-DNA $\geq$ 200,000 IU/mL인 경우 나. 투여방법 1) 투여용량: Tenofovir disoproxil 300mg를 1일 1회	가. 3항의 각 투여기간 이후 나. HBsAg(+) 또는 HBV-DNA(+)로서 B형간염 재활성화 위험*이 저위험군에 해당하는 항암화학요법(cytotoxic chemotherapy) 또는 면역억제요법을 받는 환자에게 투여하는 경우 <u>*위험도 판단은 최신 가이드라인을 따라 적용함</u> <u><추 가></u> ※ 대상 약제 Lamivudine, Clevudine, Telbivudine, Entecavir, Adefovir, Tenofovir disoproxil, <u>Tenofovir alafenamide</u> <u><추 가></u> 경구제 5. B형간염 수직감염 예방 목적으로 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정함. - 아 래 - 가. 투여대상 ○ HBsAg(+)인 임산부로서 HBV-DNA $\geq$ 200,000 IU/mL인 경우 나. 투여방법 1) 투여용량: Tenofovir disoproxil 300mg 또는	

[일반원칙]

구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
	경구 투여 2) 투여기간: 임신 24주~32주에 투여를 시작하여 출산 후 최대 12주까지 급여 인정 6. 교체투여는 내성, 치료반응 불충분(부분 바이러스 반응*) 및 무반응(일차 무반응*), 임신, 객관적으로 증명된 심한 부작용에는 급여인정하며, 복약 순응도 개선 필요, 비용효과성 개선 등은 의학적 타당성을 감안하여 사례별로 급여인정함. ※ 최신 대한간학회 만성 B형간염 진료 가이드라인 등을 참고하여야 함.	<u>Tenofovir alafenamide 25mg <추 가></u>를 1일 1회 경구 투여 2) 투여기간: 임신 24주~32주에 투여를 시작하여 출산 후 최대 12주까지 급여 인정 6. 교체투여는 내성, 치료반응 불충분(부분 바이러스 반응*) 및 무반응(일차 무반응*), 임신, 객관적으로 증명된 심한 부작용에는 급여인정하며, 복약 순응도 개선 필요, 비용효과성 개선 등은 의학적 타당성을 감안하여 사례별로 급여인정함. ※ 최신 대한간학회 만성 B형간염 진료 가이드라인 등을 참고하여야 함.	

※ 관련근거

- 식품의약품안전처 허가사항
- Harrison's Principles of Internal Medicine, 22e, 2025> Chapter 352: Chronic Hepatitis
- Goldman-Cecil Medicine, 27e, 2024> Chapter 135. CHRONIC VIRAL AND AUTOIMMUNE HEPATITIS
- Greenberger's CURRENT Diagnosis & Treatment Gastroenterology, Hepatology, & Endoscopy, 4e, 2022> Chapter 41: Viral Hepatitis
- Sleisenger and Fordtran's Gastrointestinal and Liver Disease, 11e, 2021> Chapter 79. Hepatitis B
- 대한간학회. 2022 대한간학회 만성 B형간염 진료 가이드라인.
- 대한간학회. 2018 대한간학회 만성 B형간염 진료 가이드라인.
- European Association for the Study of the Liver. EASL Clinical Practice Guidelines on the management of hepatitis B virus

[일반원칙]

구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
infection. J Hepatol. 2025 Aug;83(2):502–583. doi: 10.1016/j.jhep.2025.03.018. · Terrault NA, et al. Update on Prevention, Diagnosis, and Treatment of Chronic Hepatitis B: AASLD 2018 Hepatitis B Guidance. Clin Liver Dis (Hoboken). 2018 Aug 22;12(1):33–34. · Society for Maternal-Fetal Medicine (SMFM). Society for Maternal-Fetal Medicine Consult Series #69: Hepatitis B in pregnancy: updated guidelines. Am J Obstet Gynecol. 2024 Apr;230(4):B2–B11. · Clinical Practice Guidelines Committee Chair; Osioy C, et al. The Management of Chronic Hepatitis B: 2025 Guidelines Update from the Canadian Association for the Study of the Liver and Association of Medical Microbiology and Infectious Disease Canada. Can Liver J. 2025 May 26;8(2):368–440. · World Health Organization. Guidelines for the prevention, diagnosis, care and treatment for people with chronic hepatitis B infection [Internet]. Geneva: World Health Organization; 2024 Mar. · Janssen HLA, et al. Switching to tenofovir alafenamide in patients with virologically suppressed chronic hepatitis B and renal or hepatic impairment: final week 96 results from an open-label, multicentre, phase 2 study. Lancet Gastroenterol Hepatol. 2024 Aug;9(8):718–733 · Qiu X, et al. Effectiveness and safety of tenofovir amibufenamide and tenofovir alafenamide in treating elderly patients diagnosed with decompensated hepatitis B cirrhosis: a retrospective cohort study. Front Pharmacol. 2025 Apr 3;16:1545108 · Rong X, et al. Efficacy and Safety of Tenofovir Amibufenamide and Tenofovir Alafenamide for First-Time HBV-Related Decompensated Cirrhosis. J Viral Hepat. 2025 Apr;32(4):e14029. · Bektas E, et al. Virological and Biochemical Effects of Tenofovir Alafenamide in Different Patient Groups With Chronic Hepatitis B Virus Infection in Real-World Cohort. Int J Hepatol. 2025 Apr 15;2025:9632839. · Bektas E, et al. Real World Efficacy and Safety of Switching From Tenofovir Disoproxil Fumarate to Tenofovir Alafenamide in Liver Transplant Recipients. Transpl Infect Dis. 2025 Jul 2:e70068. · Rashidi-Alavijeh J, et al. Safety and efficacy of tenofovir alafenamide in liver transplant recipients: A single center experience. Transpl Infect Dis. 2021 Jun;23(3):e13522.			

[일반원칙]			
구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
· Liu JK, et al. Renal Outcomes With Tenofovir Alafenamide in Liver Transplant Recipients. Clin Gastroenterol Hepatol. 2023 Feb;21(2):538-540.e4. · Lee IC, et al. Efficacy and Renal Safety of Prophylactic Tenofovir Alafenamide for HBV-Infected Cancer Patients Undergoing Chemotherapy. Int J Mol Sci. 2022 Sep 26;23(19):11335. · Pan CQ, et al. Tenofovir Alafenamide Versus Tenofovir Disoproxil Fumarate for Preventing Vertical Transmission in Chronic Hepatitis B Mothers: A Systematic Review and Meta-Analysis. Clin Infect Dis. 2024 Oct 15;79(4):953-964. · Zeng QL, et al. Expected 8-Week Prenatal vs 12-Week Perinatal Tenofovir Alafenamide Prophylaxis to Prevent Mother-to-Child Transmission of Hepatitis B Virus: A Multicenter, Prospective, Open-Label, Randomized Controlled Trial. Am J Gastroenterol. 2025 May 1;120(5):1045-1056. · Byun KS, et al. Tenofovir Alafenamide for Drug-Resistant Hepatitis B: A Randomized Trial for Switching From Tenofovir Disoproxil Fumarate. Clin Gastroenterol Hepatol. 2022 Feb;20(2):427-437.e5. · Ali FS, et al. AGA Clinical Practice Guideline on the Prevention and Treatment of Hepatitis B Virus Reactivation in At-Risk Individuals. Gastroenterology. 2025 Feb;168(2):267-284. · Papatheodoridi M, et al. Risk of HBV reactivation during therapies for HCC: A systematic review. Hepatology. 2022 May;75(5):1257-1274.			

[일반원칙]				
구 분	세부인정기준 및 방법			사유
	현 행		개 정(안)	
[일반원칙] 당뇨병용제	(생 략) ※ 대상약제 [경구제 중 단일제] (생 략) [경구제 중 2제 복합제]		(현행과 같음) ※ 대상약제 [경구제 중 단일제] (현행과 같음) [경구제 중 2제 복합제]	○ ‘엠파글리포진10/100밀리그램’ 등 Empagliflozin을 포함하는 복합제가 등재예정임에 따라 「[일반원칙] 당뇨병용제」 대상약제 ‘경구제 중 2제 복합제’ 중 ‘SGLT-2 inhibitor계+DPP-IV inhibitor계’ 성분군에 ‘Empagliflozin+Sitagliptin phosphate’ 성분명을 추가함.
	성분군	성분명	성분군	
	Sulfonylurea계 +Biguanide계	Glibenclamide+Metformin HCl, Gliclazide+Metformin HCl, Glimepiride+Metformin HCl	Sulfonylurea계 +Biguanide계	
	Meglitinide계 +Biguanide계	Mitiglinide calcium hydrate+Metformin HCl, Nateglinide+Metformin HCl, Repaglinide+Metformin HCl	Meglitinide계 +Biguanide계	
	α-glucosidase inhibitor계 +Biguanide계	Voglibose+Metformin HCl	α-glucosidase inhibitor계 +Biguanide계	

[일반원칙]

구 분	세부인정기준 및 방법				사유
	현 행		개 정(안)		
	성분군	성분명	성분군	성분명	
	Thiazolidinedione계 +Biguanide계	Lobeglitazone sulfate +Metformin HCl, Pioglitazone HCl +Metformin HCl	Thiazolidinedione계 +Biguanide계	Lobeglitazone sulfate +Metformin HCl, Pioglitazone HCl +Metformin HCl	
	Thiazolidinedione계 +Sulfonylurea 계	Pioglitazone HCl+Glimepiride, Rosiglitazone maleate+Glimepiride	Thiazolidinedione계 +Sulfonylurea 계	Pioglitazone HCl+Glimepiride, Rosiglitazone maleate+Glimepiride	
	Thiazolidinedione계 +DPP-IV inhibitor계	Pioglitazone HCl+Alogliptin, Lobeglitazone sulfate+Sitagliptin phosphate, Pioglitazone HCl +Sitagliptin phosphate	Thiazolidinedione계 +DPP-IV inhibitor계	Pioglitazone HCl+Alogliptin, Lobeglitazone sulfate+Sitagliptin phosphate, Pioglitazone HCl +Sitagliptin phosphate	
	DPP-IV inhibitor계 +Biguanide계	Alogliptin+Metfor min HCl, Anagliptin+Metfor	DPP-IV inhibitor계 +Biguanide계	Alogliptin+Metfor min HCl, Anagliptin+Metfor	

[일반원칙]

구 분	세부인정기준 및 방법				사유
	현 행		개 정(안)		
	성분군	성분명	성분군	성분명	
		min HCl, Evogliptin+Metfor min HCl, Gemigliptin+Metfor min HCl, Linagliptin+Metfor min HCl, Linagliptin besylate +Metformin HCl, Saxagliptin+Metfor min HCl, Sitagliptin phosphate +Metformin HCl, Sitagliptin HCl+Metformin HCl, Teneligliptin HBr+Metformin		min HCl, Evogliptin+Metfor min HCl, Gemigliptin+Metfor min HCl, Linagliptin+Metfor min HCl, Linagliptin besylate +Metformin HCl, Saxagliptin+Metfor min HCl, Sitagliptin phosphate +Metformin HCl, Sitagliptin HCl+Metformin HCl, Teneligliptin HBr+Metformin	

[일반원칙]					
구 분	세부인정기준 및 방법				사유
	현 행		개 정(안)		
	성분군	성분명	성분군	성분명	
		HCl, Teneligliptin HCl+Metformin HCl, Teneligliptin ditosylate +Metformin HCl, Vildagliptin+Metfor min HCl, Vildagliptin HCl+Metformin HCl, Vildagliptin nitrate+Metformin HCl		HCl, Teneligliptin HCl+Metformin HCl, Teneligliptin ditosylate +Metformin HCl, Vildagliptin+Metfor min HCl, Vildagliptin HCl+Metformin HCl, Vildagliptin nitrate+Metformin HCl	
	SGLT-2 inhibitor계 +Biguanide계	Dapagliflozin+Metf ormin HCl, Empagliflozin+Metf ormin HCl, Enavogliflozin+Met formin HCl	SGLT-2 inhibitor계 +Biguanide계	Dapagliflozin+Metf ormin HCl, Empagliflozin+Metf ormin HCl, Enavogliflozin+Met formin HCl	
	SGLT-2	Dapagliflozin+Glim	SGLT-2	Dapagliflozin+Glim	

[일반원칙]				
구 분	세부인정기준 및 방법			
	현 행		개 정(안)	
	성분군	성분명	성분군	성분명
	inhibitor계+Sulfonyl urea계	epiride	inhibitor계+Sulfonyl urea계	epiride
	SGLT-2 inhibitor계+DPP-IV inhibitor계 (단, Metformin HCl 병용 시에만 요양급여 인정)	Dapagliflozin+Gemi gliptin, Dapagliflozin+Sitag liptin phosphate, Dapagliflozin+Sitag liptin HCl, Dapagliflozin+Saxa gliptin, Dapagliflozin+Evog liptin, Dapagliflozin+Lina gliptin, Empagliflozin+Lina gliptin, <u><추 가></u>	SGLT-2 inhibitor계+DPP-IV inhibitor계 (단, Metformin HCl 병용 시에만 요양급여 인정)	Dapagliflozin+Gemi gliptin, Dapagliflozin+Sitag liptin phosphate, Dapagliflozin+Sitag liptin HCl, Dapagliflozin+Saxa gliptin, Dapagliflozin+Evog liptin, Dapagliflozin+Lina gliptin, Empagliflozin+Lina gliptin, <u>Empagliflozin+Sitag liptin phosphate,</u>

[일반원칙]

구 분	세부인정기준 및 방법				사유
	현 행		개 정(안)		
	성분군	성분명	성분군	성분명	
		Ertugliflozin+Sitagliptin phosphate		Ertugliflozin+Sitagliptin phosphate	
	SGLT-2 inhibitor계+Thiazolidinedione계 (단, Metformin HCl 병용 시에만 요양급여 인정)	Dapagliflozin+Pioglitazone HCl	SGLT-2 inhibitor계+Thiazolidinedione계 (단, Metformin HCl 병용 시에만 요양급여 인정)	Dapagliflozin+Pioglitazone HCl	
	[경구제 중 3제 복합제] (생 략) [주사제] (생 략)		[경구제 중 3제 복합제] (현행과 같음) [주사제] (현행과 같음)		
※ 관련근거 <요양급여 신규등재에 따른 급여기준 신설>					

[629] 기타의 화학약품제

구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	

[629] 기타의 화학요법제

구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
[629] Ledipasvir + Sofosbuvir 경구제 (품명: 하보니정)	<추 가>허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - <u>가. 대상 환자: 성인 및 만 12세 이상 18세 미만</u> <u>소아 만성 C형 간염환자</u> - 이전 치료 경험이 없는 환자 또는 - 이전 치료 경험에 실패한 환자(페그인터페론 알파/리바비린 또는 HCV 프로테아제 저해제+페그인터페론/리바비린 요법 포함) ※ 페그인터페론 알파 치료 실패: 부작용이나 낮은 순응도로 인한 사용중지, 치료 무반응 또는 부분반응, 재발, 바이러스 돌파현상 나. 투여 방법 및 기간 <u>1) 성인 만성 C형 간염환자</u>	1. 허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - <u>가. 투여대상</u> <u>성인, 만 12세 이상 18세 미만 소아 만성 C형 간염으로 다음과 같은 경우</u> - 다 음 - 1) 이전 치료 경험이 없는 경우 2) 이전 치료 경험에 실패한 경우(페그인터페론 알파/리바비린 또는 HCV 프로테아제 저해제+페그인터페론/리바비린 요법 포함) ※ 페그인터페론 알파 치료 실패: 부작용이나 낮은 순응도로 인한 사용중지, 치료 무반응 또는 부분반응, 재발, 바이러스 돌파현상 나. 투여 방법 <u>1) 성인 만성 C형 간염</u>	○ 교과서 가이드라인 임상 연구문헌, 전문가 의견 등을 고려하여, ‘만성 C형 간염의 비대상성 간경변에 리바비린을 사용할 수 없는 경우, 단독요법 관련 급여기준을 확대함. ○ 급여기준 가독성 향상을 위하여 관련 문구 및 용어 등을 정비함.

[629] 기타의 화학요법제

구 분	세부인정기준 및 방법				사유
	현 행		개 정(안)		
	환자군		투여 방법·기간		가) 유전자 1형 <u>(1) 이전 치료에 경험이 없으면서, 간경변 없거나 대상성 간경변이 있는 경우: 단독 12주</u> <u>(2) 이전 치료에 경험이 있으면서, 간경변이 없는 경우: 단독 12주 또는 리바비린 병용 12주</u> <u>(3) 이전 치료에 경험이 있으면서, 대상성 간경변이 있는 경우: 단독 24주 또는 리바비린 병용 12주</u> <u>(4) 간이식 상태와 관계없이 비대상성 간경변이 있는 경우: 리바비린 병용 12주</u> 나) 유전자 1, 4형 <u>○ 간 이식 후 간경변이 없거나 대상성 간경변이 있는 경우: 리바비린 병용 12주</u> 다) 유전자 2, 4, 5, 6형 <u>○ 간경변이 없거나, 대상성 간경변이 있는 경우: 단독 12주</u> 2) 만 12세 이상 18세 미만 소아 만성 C형 간염 가) 유전자 1형: 단독 12주
	유전자 형 1형	이전 치료 경험이 없는 환자	간경변 없거나 대상성 간경변 있음	이 약 12주	
		이전 치료 경험이 있는 환자	간경변 없음	이 약 12주 또는 이 약+리바비린 12주	
			대상성 간경변 있음	이 약 24주 또는 이 약+리바비린 12주	
		간이식 상태와 관계없이 비대상성 간경변 환자		이 약+리바비린 12주	
	유전자 형 1, 4형	간 이식 후 환자	간경변이 없거나 대상성 간경변 있음	이 약+리바비린 12주	
	유전자 형 2, 4, 5, 6형	이전 치료경험이 없는 환자	간경변이 없거나 대상성 간경변 있음	이 약 12주	
		이전 치료 경험이 있는 환자			
	2) 만 12세 이상 18세 미만 소아 만성 C형 간염 환자				

[629] 기타의 화학요법제

구 분	세부인정기준 및 방법				사유
	현 행			개 정(안)	
	환자군		투여 방법·기간		(1) <u>이전 치료 경험이 없고, 간경변이 없거나 대상성 간경변이 있는 경우</u> (2) <u>이전 치료 경험이 있고, 간경변이 없는 경우</u> <u>나) 유전자 2, 4, 5, 6형: 단독 12주</u> <u>○ 간경변이 없거나 대상성 간경변이 있는 경우</u> <u>2. 허가사항 범위를 초과하여 아래와 같은 기준으로 투여시 요양급여를 인정함.</u> - 아 래 - <u>가. 투여대상:</u> <u>성인 만성 C형 간염</u> <u>나. 투여 방법</u>
	유전자 형 1형	이전 치료 경험이 없는 환자	간경변 없거나 대상성 간경변 있음	이 약 12주	
		이전 치료 경험이 있는 환자	간경변 없음	이 약 12주	
	유전자 형 2, 4, 5, 6형	이전 치료 경험이 없는 환자	간경변이 없거나 대상성 간경변 있음	이 약 12주	
		이전 치료 경험이 있는 환자			
	<추 가>				

[629] 기타의 화학요법제

구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
	<u>다.</u> 혈중 ALT(Alanine Transaminase) 수치 증가 등 환자상태에 따라 Hepatotonics(Carduus marianus ext., Ursodeoxycholic acid, DDB 함유 제제 등)와의 병용투여는 인정 가능하나, 동 약제와 Hepatotonics 중 1종의 약값 전액을 환자가 부담토록 함.	1) 유전자 1형 (단독 24주) <u>○ 간이식 상태와 관계없이 부작용 등 리바비린을 투여할 수 없는 비대상성 간경변이 있는 경우</u> <u>3.</u> 혈중 ALT(Alanine Transaminase) 수치 증가 등 환자상태에 따라 Hepatotonics(Carduus marianus ext., Ursodeoxycholic acid, DDB 함유 제제 등)와의 병용투여는 인정 가능하나, 동 약제와 Hepatotonics 중 1종의 약값 전액을 환자가 부담토록 함.	

※ 관련근거

- Harrison's Principles of Internal Medicine, 21st edition, 2022.
- 만성 C형 간염 진료 가이드라인, 2025, 대한간학회.
- EASL(European Association for the Study of the Liver) recommendations on treatment of hepatitis C, 2020.
- Hepatitis C Guidance 2023 Update: American Association for the Study of Liver Diseases(AASLD) Infectious Diseases Society of America(IDSA) Recommendations for Testing, Managing, and Treating Hepatitis C Virus Infection), 2023.
- Michael Charlton et al. Ledipasvir and Sofosbuvir Plus Ribavirin for Treatment of HCV Infection in Patients With Advanced Liver Disease, Gastroenterology, 2015.
- Michael Charlton et al. Ledipasvir and Sofosbuvir Plus Ribavirin for Treatment of HCV Infection in Patients With Advanced Liver Disease, The Lancet Infectious Diseases, 2016.
- Gheorghe, L. S. et al. Efficacy and Safety of Ledispavir/Sofosbuvir with or without Ribavirin in patients with Decompensated

[629] 기타의 화학료법제			
구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
Liver Cirrhosis and Hepatitis C Infection: a Cohort Study, Gastroenterology, 2020.			
• NICE, Ledipasvir-sofosbuvir for treating chronic hepatitis C, 2015.			
• PBAC, Public Summary Document, LEDIPASVIR 90 MG / SOFOSBUVIR400mg fixed dose combination tablet, Harvoni®, Gilead Sciences Pty Ltd, Gilead Sciences Pty Ltd, 2015.			
• SMC, ledipasvir/sofosbuvir, 90mg/400mg, film-coated tablet (Harvoni®), SMC No. (1030/15), No.(1084/15) Gilead Sciences Ltd, 2015.			
• CADTH, LEDIPASVIR/SOFOSBUVIR (Harvoni – Gilead Sciences Canada, Inc.). Indication: Chronic Hepatitis C Virus Genotype 1 Infection in Adults, 2016.			

[629] 기타의 화학료법제			
구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
[629] Sofosbuvir + Velpatasvir 경구제	<추 가>허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - 가. 대상 환자 및 투여 방법·기간	1. 허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - 가. 투여대상	○ 교과서 가이드라인 임상연구문헌, 전문가 의견 등을 고려하여, ‘만성 C형 간염의 비대상성 간경변에 리바비린을 사용할 수 없는 경우, 단

[629] 기타의 화학요법제

구 분	세부인정기준 및 방법				사유	
	현 행			개 정(안)		
(품명: 엠플루사정)	대상 환자: 성인 및 만 12세 이상이고 체중 30kg 이상인 소아 만성 C형 간염 환자 중			투여 방법· 기간	<u>성인, 만 12세 이상이고 체중 30kg이상인 소아의 유전자 1,2,3,4,5,6형 만성 C형 간염</u>	독요법 관련 급여기준을 확대함. ○ 급여기준 가독성 향상을 위하여 관련 문구 및 용어 등을 정비함.
	유전자형 1,2,3,4,5 ,6형	이전 치료 경험이 없는 환자	간 경 변 이 없거나 대상성 간 경변 있음	이 약 12주		
		인터페론, 페그인터페론 및/또는 리바비린 치료에 실패한 환자				
		이전 치료 경험이 없는 환자	비 대 상 성 간경변 있 음	이 약 + 리바 비린 12주		
		인터페론, 페그인터페론 및/또는 리바비린 치료에 실패한 환자				
※ 이전 치료에 실패: 부작용이나 낮은 순응도로 인한 사용중지, 치료 무반응 또는 부분반응, 재발, 바이러스 돌파현상						
<추 가>					<u>나. 투여방법</u> <u>이전 치료 경험이 없거나, 인터페론, 페그인터페론± 리바비린 치료에 실패한 경우 다음과 같이 투여</u> - 다 음 - 1) 간경변이 없거나 대상성 간경변 있는 경우: <u>단독 12주</u> 2) 비대상성 간경변 있는 경우: 리바비린 병용 12주 <u>※ 이전 치료에 실패: 부작용이나 낮은 순응도로 인한 사용중지, 치료 무반응 또는 부분반응, 재발, 바이러스 돌파현상</u> <u>2. 허가사항 범위를 초과하여 아래와 같은 기준으 로 투여 시 요양급여를 인정함.</u> - 아 래 - <u>가. 투여대상</u> <u>성인, 만 12세 이상이고 체중 30kg이상인 소아의 유전자 1,2,3,4,5,6형 만성 C형 간염</u>	

<추 가>

[629] 기타의 화학료법제

구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
	<u>나.</u> 혈중 ALT(Alanine Transaminase) 수치 증가 등 환자상태에 따라 Hepatotonics(Carduus marianus ext., Ursodeoxycholic acid, DDB 함유 제제 등)와의 병용투여는 인정 가능하나, 동 약제와 Hepatotonics 중 1종의 약값 전액을 환자가 부담토록 함.	<u>나. 투여방법</u> <u>다음은 모두 만족하고, 비대상성 간경변이 있는 경우 동 약제 24주 단독 인정</u> <u>- 다 음 -</u> 가) <u>이전 치료 경험이 없거나, 인터페론, 페그인터페론± 리바비린 치료에 실패한 경우</u> 나) <u>부작용 등 리바비린을 투여할 수 없는 경우</u> <u>※ 이전 치료에 실패: 부작용이나 낮은 순응도로 인한 사용중지, 치료 무반응 또는 부분반응, 재발, 바이러스 돌파현상</u> <u>3.</u> 혈중 ALT(Alanine Transaminase) 수치 증가 등 환자상태에 따라 Hepatotonics(Carduus marianus ext., Ursodeoxycholic acid, DDB 함유 제제 등)와의 병용투여는 인정 가능하나, 동 약제와 Hepatotonics 중 1종의 약값 전액을 환자가 부담토록 함.	
※ 관련근거 • Harrison's Principles of Internal Medicine, 21st edition, 2022.			

[629] 기타의 화학료법제			
구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
• 만성 C형 간염 진료 가이드라인, 2025, 대한간학회. • EASL(European Association for the Study of the Liver) recommendations on treatment of hepatitis C, 2020. • Hepatitis C Guidance 2023 Update: American Association for the Study of Liver Diseases(AASLD) Infectious Diseases Society of America(IDSA) Recommendations for Testing, Managing, and Treating Hepatitis C Virus Infection), 2023. • Michael P. Curry et al. Sofosbuvir and Velpatasvir for HCV in Patients with Decompensated Cirrhosis, New England Journal of Medicine, 2015. • Hussien Ahmed et al. Safety and efficacy of sofosbuvir plus velpatasvir with or without ribavirin for chronic hepatitis C virus infection: A systematic review and meta-analysis, 2017, Journal of Infection and Public Health. • NICE, Sofosbuvir-velpatasvir for treating chronic hepatitis C, 2017. • PBAC, Public Summary Document, SOFOSBUVIR with VELPATASVIR, Epclusa®, Gilead Sciences Pty Ltd, 2016, 2017. • CADTH, SOFOSBUVIR/VELPATASVIR (Epclusa – Gilead Sciences Canada, Inc.). Indication: Chronic Hepatitis C Virus Infection in Adults, 2016 • SMC, sofosbuvir 400mg, velpatasvir 100mg film-coated tablets (Epclusa), 2018.			

[639] 기타의 생물학적제제			
구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
[639]	1. 허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로	1. 허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로	○ 교과서, 가이드라인,

[639] 기타의 생물학적제제

구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
Ravulizumab 주사제 (품명: 울토미리스주 등)	투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - 가. 발작성 야간 혈색소뇨증(PNH: Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria) (생 략) 나. 비정형 용혈성 요독 증후군(aHUS: atypical Hemolytic Uremic Syndrome) (생 략)	투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - 가. 발작성 야간 혈색소뇨증(PNH: Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria) (현행과 같음) 나. 비정형 용혈성 요독 증후군(aHUS: atypical Hemolytic Uremic Syndrome) (현행과 같음) <u>다. 시신경 척수염 범주질환(NMOSD: Neuromyelitis Optica Spectrum Disorder)</u> <u>1) 투여 대상: 항아쿠아포린-4 (AQP-4) 항체 양성인 만 18세 이상의 성인 시신경 척수염 범주질환 환자로, Ravulizumab 투여 시점에 확장 장애 상태 척도(Extended Disability Status Scale, EDSS) 점수 ≤ 7 이면서 다음의 조건 중 하나를 만족하는 경우</u>	임상논문, 학회 의견, 제외국 평가결과 등을 참조하여 시신경척수염 범주질환에 급여기준을 신설함.

[639] 기타의 생물학적제제

구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
		<u>- 다 음 -</u> <u>가) 최근 1년 이내 적어도 2번의 증상 재발 또는 최근 2년 이내 적어도 3번(최근 1년 이내 1번 포함)의 증상 재발*이 있는 경우로서,</u> <u>- Rituximab 주사제의 급여기준에 적합하여 3개월 이상 해당 약제를 투여하였음에도 증상 재발이 있거나, 부작용으로 투여를 지속할 수 없는 경우</u> <u>* 전체 재발 중 1번이라도 심각한 재발(severe relapse, major relapse = nadir 시기의 단안 visual acuity (VA) < 0.1 또는 확장 장애 상태 척도(Extended Disability Status Scale, EDSS) 점수 ≥ 6)이 있어야 함.</u> <u>나) Satralizumab 주사제의 급여기준에 적합하여 3개월 이상 해당 약제를 투여하였음에도 증상 재발이 있거나, 부작용으로 투여를 지속할 수 없는 경우(※ 투여 소견서 첨부)</u>	

[639] 기타의 생물학적제제

구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
		<u>다) Eculizumab 주사제 급여기준을 만족하여 6개월 이상 급여로 투여중인 환자로 중단기준에 해당하지 않는 경우</u> <u>2) 평가 방법: 치료 시작 후 매 6개월마다 다음을 모니터링하여 투여유지 여부를 평가함.</u> <u>- 다 음 -</u> <u>가) 최초 투약시점으로부터 매 8주마다 신경학적 기능검사 확인</u> <u>나) 최초 투약시점으로부터 매 6개월마다 EDSS 확인</u> <u>3) 중단 기준 (아래의 어느 하나에 해당하는 경우)</u> <u>가) 3개월 이상 투여 이후 재발한 경우</u> <u>나) 치료제의 부작용으로 치료편의 대비 위험성이 큰 경우</u> <u>다) EDSS $\geq$ 8 인 경우</u> <u>라) 치료 효과를 평가하기 위한 6개월 간격 모니터링 자료를 제출하지 않은 경우</u>	

[639] 기타의 생물학적제제

구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
		※ 재발: 새로 발병한 신경학적인 증상 또는 기존 신경학적인 증상의 악화가 24시간 유지되는 경우(신경학적인 검사를 통해 확인한 객관적 변화로서 임상적 확인 또는 MRI 결과) ※ 신경학적인 증상 1. 시신경염 2. 급성척수염 3. 설명되지 않는 딸꾹질이나 구역과 구토 4. 급성 뇌간 증후군 5. 증상성 기면증이나 급성 간뇌증후군에서 NMOSD 특징 뇌 MRI 병변이 동반 6. 증상성 뇌증후군에서 NMOSD 특징적 뇌 또는 척수 MRI 병변이 동반 4) 동 약제는 관련 진료과(신경과, 안과) 전문의가 처방하여야 함. 5) 동 약제의 허가사항 중 ‘사용상 주의사항 (경고 등)’을 참고하여 투여하여야 하며, 투여 대상 및 지속투여 시 반응평가에 대한 객관적 자료(신경학적 기능검사 결과지, EDSS 점수, 진료기록부 등)를 반드시	

[639] 기타의 생물학적제제

구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
	2. (생 략) 3. 울토미리스주의 사전심사 방법·절차 및 위원회 구성, 사전심사 운영 기간 등에 대한 세부사항은 건강보험심사평가원장이 정함. (단, 가. 발작성 야간 혈색소뇨증의 경우, 사전승인 심사 대상에 해당되지 않음.)	<u>제출하여야 함.</u> 2. (현행과 같음) 3. 울토미리스주의 사전심사 방법·절차 및 위원회 구성, 사전심사 운영 기간 등에 대한 세부사항은 건강보험심사평가원장이 정함. (단, 가. 발작성 야간 혈색소뇨증과 다. <u>시신경척수염범주질환(NMOSD)</u>의 경우, 사전승인 심사 대상에 해당되지 않음.)	

※ 관련근거

1. Harrison's Principles of Internal Medicine, 21e > Chapter 445: Neuromyelitis Optica
2. Clinical Neurology & Neuroanatomy: A Localization Based Approach, 2e > Chapter 21: Demyelinating Diseases of the Central Nervous System
3. Ferri's Clinical Advisor 2025 > 770.e15 Neuromyelitis Optica Spectrum Disorder
4. Update on the diagnosis and treatment of neuromyelitis optica spectrum disorders (NMOSD) – revised recommendations of the Neuromyelitis Optica Study Group (NEMOS). Part II: Attack therapy and long term management J. Neurol. 2024;271:141–176
5. International Delphi Consensus on the Management of AQP4-IgG+ NMOSD Recommendations for Eculizumab, Inebilizumab, and Satralizumab Neurol Neuroimmunol Neuroinflamm 2023;10:e200124.
6. Diagnose und Therapie der Multiplen Sklerose, Neuromyelitis-optica-Spektrum-Erkrankungen und MOG-IgG-assoziierten Erkrankungen Deutschen Gesellschaft für Neurologie 2023.

[639] 기타의 생물학적제제

구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
7.	多發性硬化症・視神釋脊髓炎 スペクトラム障害 診療ガイドライン 日本神経學會 2023		
8.	시신경척수염 범주질환 환자를 위한 안내 책자. 한국다발성경화증협회(대한신경면역학회). 2023.		
9.	S.J. Pittock et al, Ravulizumab in Aquaporin-4-Positive Neuromyelitis Optica Spectrum Disorder, Ann Neurol 2023;93:1053-68.		
10.	S.J. Pittock et al, Eculizumab in Aquaporin-4-Positive Neuromyelitis Optica Spectrum Disorder, N Engl J Med 2019;381:614-25.		
11.	T. Yamamura et al, Trial of Satralizumab in Neuromyelitis Optica Spectrum Disorder, N Engl J Med 2019;381:2114-24.		
12.	A. Traboulsee et al, Safety and efficacy of satralizumab monotherapy in neuromyelitis optica spectrum disorder: a randomised, double-blind, multicentre, placebo-controlled phase 3 trial Lancet Neurol 2020;19:402-12.		
13.	BA C Cree et al, Inebilizumab for the treatment of neuromyelitis optica spectrum disorder (N-MOMentum): a double-blind, randomised placebo-controlled phase 2/3 trial Lancet 2019;394:1352-63.		
14.	M Tahara et al, Safety and efficacy of rituximab in neuromyelitis optica spectrum disorders (RIN-1 study): a multicentre, randomised, double-blind, placebo-controlled trial Lancet Neurol 2020;19:298-306.		
15.	C Zhang et al, Safety and efficacy of tocilizumab versus azathioprine in highly relapsing neuromyelitis optica spectrum disorder (TANGO): an open-label, multicentre, randomised, phase 2 trial Lancet Neurol 2020;19:391-401.		
16.	SL Clardy et al, Network Meta-analysis of Ravulizumab and Alternative Interventions for the Treatment of Neuromyelitis Optica Spectrum Disorder Neurol Ther 2024;13:535-49.		
17.	HL Lee et al, Results of a Survey on Diagnostic Procedures and Treatment Choices for Neuromyelitis Optica Spectrum Disorder in Korea: Beyond the Context of Current Clinical Guidelines J Clin Neurol 2022;18(2):207-13.		
18.	CADTH Reimbursement Recommendation: Ravulizumab(Ultomiris)Indication: For the treatment of adult patients with anti-aquaporin 4 (AQP4) antibody-positive neuromyelitis optica spectrum disorder (NMOSD)(2024.4.)		
19.	CADTH Rituximab for the Treatment of Neuromyelitis Optica Spectrum Disorder(2021.2.)		

[639] 기타의 생물학적제제			
구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
20. Ontario Exceptional Access Program Reimbursement Criteria for Frequently Requested Drugs(2023.12.18.)			
21. PHARMACEUTICAL BENEFITS ADVISORY COMMITTEE (PBAC) MEETING OUTCOMESNOVEMBER 2024 PBAC MEETING			
22. PHARMACEUTICAL BENEFITS ADVISORY COMMITTEE (PBAC) MEETING OUTCOMESSEPTEMBER 2021 PBAC MEETING			